ऊपरी और बीच की पीठ दर्द जांच रिपोर्ट

बनाई गई: 4 नव॰ 2026, 3:21 am

यह टूल यह तय करने में मदद करता है कि इलाज कितनी जल्दी लें और किस विशेषज्ञ को दिखाएं। यह डायग्नोसिस या इलाज नहीं करता, और डॉक्टर की जांच की जगह नहीं लेता। तबीयत बहुत खराब लगे या चिंता हो, तो अस्पताल जाएं।

24–48 घंटे में डॉक्टर को दिखाएं

ठीक होने का इंतज़ार न करें। सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट लें या अस्पताल की OPD जाएं।

- एक तरफ पट्टी में जलन या दाने: शिंगल्स का इलाज 72 घंटे के अंदर सबसे असरदार
- 18 से कम या 60 से ज़्यादा उम्र
- तेज़ दर्द (10 में 7–8)

क्लिनिकल आकलन

सबसे संभावित: शिंगल्स (हर्पीज़ ज़ोस्टर) [मज़बूत मेल]

Herpes zoster of a thoracic dermatome

पक्ष में: एक तरफ पट्टी में दाने या छाले · एक तरफ छाती के चारों ओर पट्टी जैसा दर्द · त्वचा में जलन, झुनझुनी, छूने से दर्द · छाती और पसलियों का साइड · 60 या ज़्यादा · इस बार का दर्द पिछले 1 हफ्ते के अंदर शुरू हुआ

चिकनपॉक्स का वायरस एक नस में फिर सक्रिय होता है, जिससे पीठ और छाती के एक तरफ पट्टी में जलन वाला दर्द होता है। दाने आमतौर पर दर्द शुरू होने के 2–3 दिन बाद आते हैं।

आपके जवाब यहाँ क्यों इशारा करते हैं

- एक तरफ पट्टी में दाने या छाले — एक तरफ पट्टी में दाने लगभग हमेशा शिंगल्स होते हैं।
- एक तरफ छाती के चारों ओर पट्टी जैसा दर्द — छाती के एक तरफ पट्टी जैसा दर्द एक थोरेसिक नस के रास्ते पर होता है।
- त्वचा में जलन, झुनझुनी, छूने से दर्द — जलन वाली, छूने से दुखती त्वचा शिंगल्स जैसे नस दर्द का खास लक्षण है।
- छाती और पसलियों का साइड — पसली के साथ दर्द इंटरकोस्टल नस या पसली के जोड़ के रास्ते पर होता है।
- 60 या ज़्यादा — 60 के बाद स्टेनोसिस और फ़ैसेट गठिया जैसी घिसावट वाली समस्याएं आम हैं।

यह क्यों होता है: 50 के बाद और कम इम्युनिटी (डायबिटीज़, स्टेरॉयड, कीमोथेरेपी, HIV) में ज़्यादा आम; लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को जीवन में होता है।

डॉक्टर कैसे पुष्टि करते हैं: आमतौर पर डॉक्टर दानों के पैटर्न से पहचानते हैं।

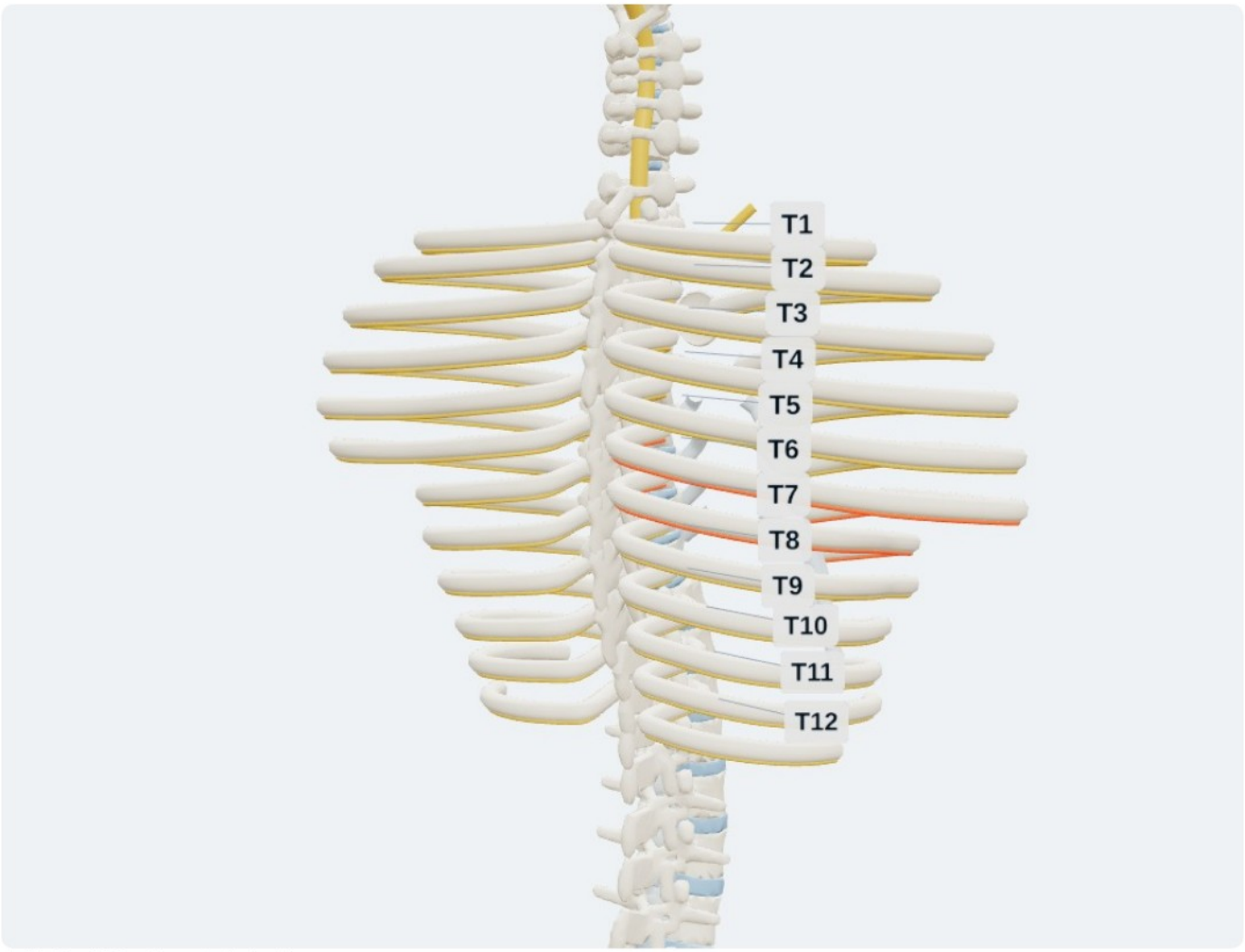
इलाज कैसे होता है: एंटीवायरल गोलियाँ दाने के 72 घंटे के अंदर शुरू हों तो सबसे अच्छा असर, साथ में दर्द की दवा। बुज़ुर्गों में टीका इसे रोकता है।

आगे क्या होता है: दाने 2–4 हफ्तों में ठीक; कुछ लोगों में लंबा नस दर्द (पोस्ट-हर्पेटिक न्यूरेल्जिया) रहता है।

डॉक्टर की जांच ज़रूरी है

- यह जांच आपके रिफ्लेक्स, मांसपेशियों की ताकत या त्वचा की संवेदना नहीं परख सकती, जिनसे पता चलता है कि कौन सी नस और कितनी प्रभावित है।
- MRI, एक्स-रे या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं, यह सिर्फ डॉक्टर तय कर सकते हैं और जांच के साथ उनका मतलब समझा सकते हैं।
- ऐसा ही दर्द कूल्हे, गुर्दे, पेल्विस या पेट से भी हो सकता है; डॉक्टर इनकी भी जांच करते हैं।
- दवाएं, इंजेक्शन और व्यायाम योजना आपके लिए व्यक्तिगत रूप से तय होनी चाहिए।

आपकी समस्या की 3D एनाटॉमी



संदर्भ के लिए थोरेसिक रीढ़, पसलियाँ और नसें।



पूरा कंकाल और नसें; चमकते हिस्से आपके संभावित कारण से जुड़े हैं।



आपके चिन्हित हिस्से, पीछे से



आपके चिन्हित हिस्से, आगे से

किस विशेषज्ञ को दिखाएं

1. त्वचा रोग / जनरल फिज़िशियन (यहाँ से शुरू करें)

शिंगल्स में एंटीवायरल दवा चाहिए, दाने के 72 घंटे के अंदर शुरू करना सबसे अच्छा। किसलिए: शिंगल्स (हर्पीज़ ज़ोस्टर).

2. जनरल फिज़िशियन

पहली जांच, ब्लड और यूरिन टेस्ट, और रेफरल। किसलिए: शिंगल्स (हर्पीज़ ज़ोस्टर).

आपके जवाब

उम्र	60 या ज़्यादा · महिला
मेडिकल इतिहास (जो लागू हो, चुनें)	कोई नहीं
चुने गए हिस्से	पीठ का बीच, रीढ़ के बगल में (दायां); छाती और पसलियों का साइड (दायां)
यह कैसे शुरू हुआ?	धीरे-धीरे, बिना साफ़ वजह
दर्द कब से है?	इस बार का दर्द पिछले 1 हफ्ते के अंदर शुरू हुआ
दर्द कैसा व्यवहार करता है?	एक तरफ छाती के चारों ओर पट्टी जैसा दर्द; त्वचा में जलन, झुनझुनी, छूने से दर्द; एक तरफ पट्टी में दाने या छाले
रोज़मर्रा पर असर	अभी दर्द 7/10 · गहरी सांस लेना: दर्द नहीं · बैठना: 30 मिनट से ज़्यादा · नींद: —
दबाने का टेस्ट	जवाब नहीं
सांस-और-मोड़ टेस्ट	जवाब नहीं
दीवार टेस्ट (पोस्चर)	जवाब नहीं
खतरे के लक्षणों की जांच	सभी खतरे के लक्षणों में "नहीं"

स्रोत

1. WHO guideline on chronic low back pain (summary, Health Policy Watch, 2023) — https://healthpolicy-watch.news/who-issues-first-guidelines-low-back-pain/
2. Orthobullets – Lumbar disc herniation — https://www.orthobullets.com/spine/2035/lumbar-disc-herniation
3. Chiu CC et al. Probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc. Clin Rehabil 2015;29:184–95 (summary) — https://www.painscience.com/biblio/intervertebral-disc-injuries-spontaneously-regress-surprisingly-often--and-worse-ones-more.html
4. Cochrane review CD007431 – Physical examination for lumbar radiculopathy due to disc herniation — https://www.cochrane.org/evidence/CD007431_physical-examination-diagnosis-lumbar-radiculopathy-due-disc-herniation-patients-low-back-pain-and
5. Brinjikji W et al. Imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR 2015;36:811–6 — https://www.ajnr.org/content/36/4/811
6. Radiology Assistant – Lumbar disc nomenclature 2.0 — https://radiologyassistant.nl/neuroradiology/spine/lumbar-disc-nomenclature-2-0
7. North American Spine Society – Bulge vs herniation — https://www.spine.org/KnowYourBack/Conditions/Degenerative-Conditions/Bulge-Herniation
8. MSD Manual – Symptoms of common radiculopathies by dermatomal level — https://www.msdmanuals.com/professional/multimedia/table/symptoms-of-common-radiculopathies-by-dermatomal-level
9. Physiopedia – Lumbar radiculopathy assessment (myotomes, reflexes) — https://www.physio-pedia.com/Lumbar_Radiculopathy_Assessment
10. Medmastery – Diagnosing lumbar radiculopathy — https://www.medmastery.com/guide/neurology-diseases-clinical-guide/diagnosing-lumbar-radiculopathy
11. NICE NG59 – Low back pain and sciatica in over 16s — https://www.nice.org.uk/guidance/ng59/chapter/Recommendation
12. Royal Free London NHS – Cauda equina syndrome warning signs — https://royalfree.nhs.uk/patients-and-visitors/patient-information-leaflets/cauda-equina-syndrome
13. WikEM – Back pain red flags — https://wikem.org/wiki/Back_pain_(red_flags)
14. MSD Manual – Lumbar spinal stenosis — https://www.msdmanuals.com/professional/musculoskeletal-and-connective-tissue-disorders/neck-and-back-pain/lumbar-spinal-stenosis
15. ASAS criteria for inflammatory back pain — https://empendium.com/mcmtextbook/table/031_6932
16. Spine-health – Vertebral fracture symptoms — https://spine-health.com/conditions/osteoporosis/vertebral-fracture-symptoms
17. Pott's disease (spinal tuberculosis) — https://en.wikipedia.org/wiki/Pott%27s_disease
18. NHS 111 Wales – Kidney stones — https://111.wales.nhs.uk/kidneystones/
19. Texas Orthopedics – Coccydynia — https://www.txortho.com/patient-education-article/coccydynia-tailbone-pain-969
20. Medical emergency numbers in India (108, 112) — https://zhl.org.in/blog/medical-emergency-numbers-india/
21. GBD 2021 Neck Pain Collaborators. Global burden of neck pain 1990–2020 and projections to 2050. Lancet Rheumatol 2024;6:e142–55 — https://research.uaeu.ac.ae/en/publications/global-regional-and-national-burden-of-neck-pain-19902020-and-pro/
22. Radhakrishnan K et al. Epidemiology of cervical radiculopathy, Rochester 1976–1990. Brain 1994 (PubMed abstract) — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8186959/
23. WikEM – Cervical radiculopathy (exam by level) — https://wikem.org/wiki/Cervical_Radiculopathy
24. Physiopedia – Clinical prediction rule for cervical radiculopathy (Wainner 2003) — https://physio-pedia.com/CPR_for_Cervical_Radiculopathy
25. Orthobullets – Cervical myelopathy — https://www.orthobullets.com/spine/2031/cervical-myelopathy
26. UK Health Security Agency – Meningitis: don't ignore the signs — https://gov.uk/government/publications/meningitis-signs-and-symptoms-poster/meningitis-dont-ignore-the-signs-and-symptoms
27. Heart attack warning signs (American Heart Association) — https://oaklawnhospital.org/services/cardiology/warning-signs-of-a-heart-attack-american-heart-association/
28. Healthdirect (Australian Government) – Upper back (thoracic) pain — https://www.healthdirect.gov.au/upper-back-thoracic-pain
29. Patient.info – Shingles (herpes zoster) — https://patient.info/health/Shingles.htm
30. Wolfe F et al. 2016 revisions to the fibromyalgia diagnostic criteria (criteria form) — https://lin-web.clarkson.edu/~lrussek/2016FMS.pdf